

TEMA 4.10 • GASTROENTEROLOGÍA

Ictericia

PERFIL EUNACOM 1.06.1.007
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Ictericia

La ictericia es la **coloración amarilla de piel, mucosas y escleras** por acumulación de bilirrubina.

Conceptos Básicos

- Bilirrubina total normal: < 1,1 mg/dL
- Ictericia visible: ≥ 2,5–3 mg/dL (no desde 1,1)
- Afecta primero las **escleróticas**, luego la piel
- La **pseudo-ictericia** (carotenemia): coloración amarillo-anaranjada solo en palmas, plantas y cara → por consumo de zanahoria/zapallo → **normal, sin riesgo**

Clasificación por Tipo de Bilirrubina

1. Hiperbilirrubinemia Indirecta (No Conjugada)

TABLA 4.10.1: CAUSA VS CLAVE DIAGNÓSTICA		
CAUSA	CLAVE DIAGNÓSTICA	
Síndrome de Gilbert	Pruebas hepáticas normales , solo ↑Bill; genético, crónico; 5-10% de la población chilena → observar	
Hemólisis	Anemia: Generalidades	Anemia hemolítica, ↑LDH, esquistocitos → tratar la anemia de base

2. Hiperbilirrubinemia Directa (Conjugada)

> Predominio directo = bilirrubina directa > 30% del total

TABLA 4.10.2: CAUSA VS PRUEBAS HEPÁTICAS CARACTERÍSTICAS	
CAUSA	PRUEBAS HEPÁTICAS CARACTERÍSTICAS
Hepatitis	↑↑ GOT (AST) y GPT (ALT) — transaminasas
Colestasia	↑ Fosfatasas alcalinas + ↑ GGT

PERLA CLÍNICA EUNACOM
Las transaminasas distinguen hepatitis de colestasia. Si suben GOT/GPT → hepatitis. Si suben FA/GGT → colestasia.

Clasificación de la Colestasia

TABLA 4.10.3: TIPO VS EJEMPLO		
TIPO	EJEMPLO	CLAVE
Crónica autoinmune	CBP, CEP	Ver artículo Hepatitis Crónica
Aguda con dolor	Coledocolitiasis	Ictericia + dolor
Aguda con dolor + fiebre	Colangitis aguda	Tríada de Charcot
Sin dolor (silente)	Cáncer	Adulto mayor amarillo → cáncer hasta descartar

Ictericia Maligna (Silente)

Causas

- **Cáncer de páncreas** (más frecuente)
- Cáncer de ampolla de Vater
- Colangiocarcinoma
- Cáncer de vesícula biliar

Clínica del Cáncer de Páncreas — Las "3D"

- **Diabetes** (FR y consecuencia: el cáncer puede causar diabetes y viceversa)
- **Depresión** (frecuente, inexplicada)
- **Dolor** crónico leve (no agudo como en coledocolitiasis)
- + Baja de peso

Pruebas Hepáticas

- **Siempre signos de colestasia:** ↑ Fosfatasas alcalinas + ↑ GGT

Estudio de la Ictericia Maligna

- ...
- Clínica sugerente (ictericia silente)
- ↓
- Ecografía abdominal (SIEMPRE PRIMERO)
- → Dilatación de vía biliar intra y extrahepática + colédoco
- ↓
- Colangio-resonancia magnética (CRCP / CPRM)
- → Examen de elección para estudio de la ictericia maligna
- ↓
- Si se sospecha cáncer de páncreas directamente: TAC abdomen
- (TAC es el gold standard para cáncer de páncreas)
- ...

EUNACOM CRITERIOS
Orden de exámenes: 1. Eco abdominal (siempre primero) 2. Colangio-resonancia (si eco solo muestra dilatación sin causa clara) 3. TAC si sospecha específica de cáncer de páncreas
La **eco siempre es el primer paso** en cualquier ictericia.

Resumen de Diagnóstico Diferencial

TABLA 4.10.4: ICTERICIA + VS PENSAR EN	
ICTERICIA +	PENSAR EN
Solo bilirrubina ↑, resto normal, crónico	Gilbert → observar
Anemia, LDH alta, esquistocitos	Hemólisis → tratar causa
↑ GOT/GPT	Hepatitis
↑ FA/GGT + dolor	Coledocolitiasis → eco → colangio-RNM → CPRE
↑ FA/GGT + dolor + fiebre	Colangitis → CPRE urgente

| ↑ FA/GGT, **sin dolor** | Cáncer → eco → colangio-RNM (o TAC si páncreas) |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Paciente de 25 años asintomático con bilirrubina total de 2.8 mg/dL a expensas de indirecta. El resto de las pruebas hepáticas son normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Ictericia. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Bilirrubina >1.1 es alta; ictericia clínica aparece sobre 2.5-3 mg/dL
- Hiperbilirrubinemia indirecta: Gilbert (pruebas hepáticas normales, benigno) y hemólisis
- Hiperbilirrubinemia directa: hepatitis (↑transaminasas) vs colestasia (↑fosfatasas alcalinas/GGT)
- Colestasia aguda con dolor = patología biliar (coledocolitiasis/colangitis)
- Ictericia sin dolor en adulto mayor = cáncer (páncreas, vesícula, ampolla de Vater)
- Cáncer de páncreas: 3D (diabetes, depresión, dolor) + baja de peso + ictericia silente
- Estudio: ecografía (1er examen) → colangiorresonancia (general) o TAC (si sospecha páncreas)

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ICTERICIA)**PREGUNTA 1**

Paciente de 25 años asintomático con bilirrubina total de 2.8 mg/dL a expensas de indirecta. El resto de las pruebas hepáticas son normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Hepatitis viral aguda
- B)** Anemia hemolítica
- C)** Síndrome de Gilbert
- D)** Coledocolitiasis
- E)** Cirrosis biliar primaria

PREGUNTA 2

Paciente de 70 años con ictericia progresiva indolora, baja de peso de 8 kg en 3 meses y diabetes de reciente diagnóstico. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica principal?

- A)** Hepatitis autoinmune
- B)** Coledocolitiasis
- C)** Cáncer de páncreas
- D)** Cirrosis biliar primaria
- E)** Síndrome de Gilbert

PREGUNTA 3

Ante la sospecha de ictericia maligna, la ecografía muestra dilatación de la vía biliar intra y extrahepática con una masa en cabeza de páncreas. ¿Cuál es el siguiente examen a solicitar?

- A)** Colangiorresonancia
- B)** TAC de abdomen y pelvis
- C)** CPRE
- D)** Biopsia hepática
- E)** Endosonografía

RESUMEN: ICTERICIA

Clase sobre el enfoque global de la ictericia. La bilirrubina >1.1 es alta; la ictericia clínica aparece sobre 2.5-3. Se divide en hiperbilirrubinemia indirecta (Gilbert y hemólisis) y directa (hepatitis con transaminasas altas vs colestasia con fosfatasas alcalinas/GGT altas). La colestasia se subdivide en: crónica autoinmune (cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria), aguda con dolor (coledocolitiasis/colangitis), y sin dolor (cáncer: páncreas, vesícula, ampolla de Vater). La ictericia maligna es silente, con dilatación de vía biliar intra y extrahepática. El estudio es ecografía → colangiorresonancia o TAC según sospecha.